



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO

Ética e Exercício Profissional

Lei 7.498/86 · Código de Ética · Processo de Enfermagem (Res.
736/2024)

Concurso de Enfermagem / Pernambuco · Cargo: Enfermeiro

PESO ALTO · PRIORIDADE MÁXIMA

Profa. Fátima Barbosa

Base legal verificada · Lei 7.498/86, COFEN 564/2017 e 736/2024

Por que este eixo derruba tanta gente

Ética e exercício profissional caem em quase toda prova — e são o terreno preferido das pegadinhas de “troca de responsável”. Dominar quem faz o quê é meio caminho para a aprovação.

Este ebook cobre três documentos que sustentam o eixo: a **Lei 7.498/86** (e seu Decreto regulamentador 94.406/87), o **Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem** (Resolução COFEN 564/2017) e a **Sistematização da Assistência de Enfermagem** (Resolução COFEN 736/2024, que substituiu a 358/2009). O foco é o que a prova cobra e as trocas que ela arma.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Lei 7.498/86** — quem é quem na enfermagem e o que é privativo do enfermeiro.
- ◆ **Código de Ética (564/2017)** — direitos, deveres, proibições e sigilo.
- ◆ **Processo de Enfermagem (736/2024)** — as cinco etapas, na redação NOVA.
- ◆ O erro nº 1 do eixo: atribuir ao técnico o que só o enfermeiro pode fazer.

Sumário

- 1** **Lei 7.498/86 — quem é quem**
 - Enfermeiro, técnico, auxiliar
 - O que é privativo
 - Prescrição de enfermagem
- 2** **As atividades privativas do enfermeiro**
 - Direção e chefia
 - Consulta de enfermagem
 - Cuidados a pacientes graves
- 3** **Código de Ética (COFEN 564/2017)**
 - Estrutura e princípios
 - Sigilo profissional
 - Infrações e penalidades
- 4** **Processo de Enfermagem (736/2024)**
 - O que mudou
 - As cinco etapas
 - O que é privativo
- 5** **Síntese e bízus finais**
 - Quadro de revisão rápida

1

Lei 7.498/86

A lei que organiza a profissão. Saber quem faz o quê resolve metade das questões.

1 • Quem é quem na enfermagem

A Lei 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Ela define quatro categorias e estabelece que o exercício só é permitido a quem tem inscrição no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) da respectiva região.

Lei 7.498/86, arts. 11 a 15 • Decreto 94.406/87

CATEGORIA	O QUE FAZ
Enfermeiro	Exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente as de maior complexidade técnica (art. 11).
Técnico de Enfermagem	Atividade de nível médio; executa ações assistenciais, exceto as privativas do enfermeiro; participa do planejamento (art. 12).
Auxiliar de Enfermagem	Nível médio, natureza repetitiva; serviços auxiliares sob supervisão; observa, reconhece e descreve sinais e sintomas (art. 13).
Parteira	Assiste a parturiente e o parto normal, nos termos da lei.

BIZU ESTRATÉGICO

Regra de ouro do art. 15: as atividades do **técnico e do auxiliar**, em instituições de saúde, só podem ser feitas **sob orientação e supervisão do enfermeiro**. Sempre que a questão “libertar” o técnico dessa supervisão, desconfie.

◆ Planejamento e prescrição de enfermagem

Dois artigos curtos que caem bastante:

- ◆ O planejamento e a programação dos serviços de saúde **incluem** o planejamento de enfermagem (art. 3º).
- ◆ A programação de enfermagem **inclui a prescrição da assistência de enfermagem** (art. 4º).

PEGADINHA CLÁSSICA

Cuidado com a expressão: a lei fala em **prescrição da assistência de enfermagem** — e não em “prescrição de medicamentos”. O enfermeiro prescreve medicamentos apenas quando previsto em **programas de saúde pública e rotinas aprovadas pela instituição**. A prova troca uma coisa pela outra.

2

As privativas do enfermeiro

O coração do eixo. É aqui que a banca mais tenta te enganar trocando o responsável.

2 · O que só o enfermeiro pode fazer

O art. 11, inciso I, lista as atividades **privativas** do enfermeiro. Estas são as mais cobradas:

- ◆ **Direção** do órgão de enfermagem da instituição e **chefia** de serviço e de unidade de enfermagem.
- ◆ **Consulta** de enfermagem.
- ◆ **Prescrição** da assistência de enfermagem.
- ◆ **Cuidados diretos** de enfermagem a pacientes graves com **risco de vida**.
- ◆ Cuidados de enfermagem de **maior complexidade técnica** e que exijam conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões imediatas.

BIZU ESTRATÉGICO

O critério que unifica quase todas as privativas é: **maior complexidade + decisão imediata**. Se a questão descreve um cuidado a paciente *grave, com risco de vida*, ou uma *consulta/prescrição de enfermagem*, ou *direção/chefia* — é do enfermeiro. Sempre.

PEGADINHA CLÁSSICA

A pegadinha mais recorrente do eixo inteiro: a banca pega uma atividade privativa (por exemplo, “cuidados diretos a paciente grave com risco de vida”) e atribui ao **técnico de enfermagem**. Leia o **sujeito** da frase antes de tudo — é ali que mora o erro.

TÉCNICO × ENFERMEIRO — NÃO CONFUNDA

- ◆ **Técnico**: executa ações assistenciais, exceto as privativas; participa do planejamento; supervisiona o auxiliar.
- ◆ **Técnico NÃO**: faz consulta de enfermagem, prescrição, diagnóstico de enfermagem nem dirige o serviço.
- ◆ **Auxiliar**: tarefas de nível médio, repetitivas, sob supervisão; observa e descreve sinais e sintomas.

3

Código de Ética

Resolução COFEN 564/2017. Princípios, sigilo e penalidades — na estrutura que a prova cobra.

3 · O Código de Ética (564/2017)

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem vigente foi aprovado pela Resolução COFEN 564/2017 e entrou em vigor em 2018, substituindo o código anterior (Resolução 311/2007). Aplica-se a enfermeiros, técnicos, auxiliares, obstetrizes e parteiras.

Resolução COFEN 564/2017

◆ Estrutura do código

O texto é organizado em capítulos, na seguinte lógica — muito cobrada em prova:

CAPÍTULO	DO QUE TRATA
Princípios fundamentais	Respeito à vida, à dignidade e aos direitos humanos; responsabilidade; qualidade e segurança do cuidado.
Direitos	O que o profissional pode exigir para exercer com segurança.
Deveres	O que o profissional deve fazer (registrar, comunicar, aplicar o processo de enfermagem).
Proibições	O que o profissional não pode fazer.
Infrações e penalidades	Classificação da gravidade e sanções aplicáveis.

◆ As penalidades

As penalidades, da mais branda à mais grave, são:

- ◆ Advertência verbal;
- ◆ Multa;
- ◆ Censura;
- ◆ Suspensão do exercício profissional;
- ◆ Cassação do direito ao exercício profissional.

BIZU ESTRATÉGICO

A ordem das penalidades cai direto. Mnemônico: “**A Multa Cansa, Suspende, Cassa**” — Advertência, Multa, Censura, Suspensão, Cassação. A advertência é *verbal*; a censura é *publicada*. Não troque uma pela outra.

◆ Sigilo profissional

Tema campeão do Código. A regra e suas exceções:

PEGADINHA CLÁSSICA

O sigilo **não é absoluto**. O profissional deve manter sigilo, **exceto**: nos casos previstos em lei, por determinação judicial, ou com consentimento escrito da pessoa. O dever **permanece** mesmo após a morte do paciente e mesmo que o fato já tenha sido divulgado publicamente. Alternativa que diz “o sigilo é absoluto e inviolável” está **errada**.

Há ainda situações de **comunicação externa obrigatória**, independentemente de autorização: casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas de consentir.

4

Processo de Enfermagem

Resolução COFEN 736/2024 — a norma NOVA. Aqui o material antigo erra feio.

4 · A Resolução 736/2024

Esta é a maior atualização recente do eixo. A Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024, substituiu a antiga 358/2009 e dispõe sobre a implementação do **Processo de Enfermagem (PE)** em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado.

Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024 (substitui a 358/2009)

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O que mudou — e por quê. A mudança mais marcante foi a **retirada do termo “Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)”**. O motivo é conceitual: pesquisas apontaram que a SAE era um conceito *abstrato e confuso*, entendido de forma diferente por cada serviço. Já o **Processo de Enfermagem** tem definição consolidada internacionalmente.

Mudou também o **nome da primeira etapa**: o que se chamava “coleta de dados / histórico de enfermagem” passou a ser **Avaliação de Enfermagem**. E a última etapa passou a ser a **Avaliação de Resultados (evolução)**. A lógica: o PE deixa de ser um formulário a preencher e passa a ser explicitamente um **método de julgamento clínico**.

◆ As cinco etapas — redação vigente

ETAPA	O QUE É
1. Avaliação de Enfermagem	Coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico), inicial e contínua. (Antiga “coleta de dados / histórico”.)
2. Diagnóstico de Enfermagem	Identificação de problemas, vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. É julgamento clínico . Privativo do enfermeiro.
3. Planejamento de Enfermagem	Plano assistencial compartilhado com a pessoa e com a equipe; define resultados esperados e a prescrição de enfermagem.
4. Implementação	Execução das ações, observadas as competências técnicas de cada profissional.
5. Avaliação de Resultados (evolução)	Verificação dos resultados alcançados e ajuste do plano.

BIZU ESTRATÉGICO

Mnemônico atualizado: “**Avaliei, Diagnostiquei, Planejei, Implementei, Avaliei o resultado**” — repare que **avaliação** abre e fecha o ciclo. As etapas são **inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas** (redação literal da 736). Continuam **privativos do enfermeiro** o *diagnóstico* e a *prescrição de enfermagem*.

PEGADINHA CLÁSSICA

Se o seu material fala em “SAE” e em “coleta de dados” citando a Resolução 358/2009, ele está **desatualizado**. A norma vigente é a **736/2024**, que retirou o termo SAE e renomeou a 1ª etapa para **Avaliação de Enfermagem**.

Cuidado com o outro lado: **bancas antigas ainda cobram a 358/2009** com a redação velha. Leia o comando — se a questão *citar a resolução*, siga a citada. Se perguntar “segundo a norma vigente”, é a **736**.

COMO A BANCA COBRA

“Segundo a Resolução COFEN nº 736/2024, a primeira etapa do Processo de Enfermagem é denominada...”

Avaliação de Enfermagem — e não “coleta de dados” ou “histórico de enfermagem”, que era a nomenclatura da 358/2009. Quando o enunciado *nomeia a resolução*, ele está testando exatamente a mudança.

PEGADINHA CLÁSSICA

Erros que permanecem: a banca inverte etapas (planejamento antes do diagnóstico) ou atribui o **diagnóstico ao técnico**. Ambas erradas — a sequência é cíclica mas ordenada, e o diagnóstico é **privativo do enfermeiro**.

5

Síntese

A página de revisão que blinda o eixo de ética.

5 · Revisão rápida do eixo

LEI 7.498 E PRIVATIVAS

- ◆ Técnico e auxiliar atuam **sob supervisão do enfermeiro** (art. 15).
- ◆ Privativas do enfermeiro: **direção/chefia, consulta, prescrição da assistência, cuidados a paciente grave com risco de vida.**
- ◆ Prescrição de enfermagem ≠ prescrição de medicamentos.
- ◆ Critério unificador: maior complexidade + decisão imediata = enfermeiro.

CÓDIGO DE ÉTICA E SAE

- ◆ Código vigente: **Resolução COFEN 564/2017.**
- ◆ Sigilo **não é absoluto**: cai por lei, ordem judicial ou consentimento escrito; permanece após óbito.
- ◆ Penalidades: Advertência, Multa, Censura, Suspensão, Cassação.
- ◆ **Processo de Enfermagem (736/2024)**: substituiu a 358/2009, **retirou o termo SAE**; 1ª etapa é **Avaliação de Enfermagem.**
- ◆ Etapas: Avaliação → Diagnóstico → Planejamento → Implementação → Avaliação de resultados.
Diagnóstico e prescrição: **privativos.**

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas que mais caem no eixo: (1) atividade privativa atribuída ao técnico; (2) sigilo descrito como absoluto; (3) etapas da SAE fora de ordem ou diagnóstico dado ao técnico. Domine essas três e você garante boa parte das questões de ética.

“Em ética, a resposta quase sempre está no sujeito da frase. Leia quem faz — antes do que se faz.”